

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES		AÑO

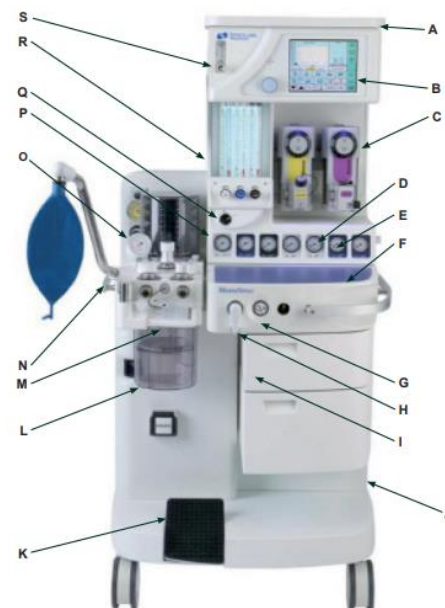


MAQUINA DE ANESTESIA

MARCA: SPACELABS HEALTHCARE
MODELO: BLASE SIRIUS

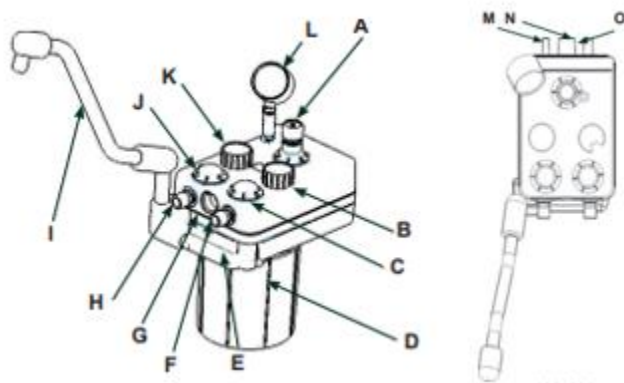
Recomendaciones antes de usar

- Revise por daños visibles, compruebe la estabilidad del equipo y la condición de las mangueras de suministro de gas.
- Revise que el equipo este correctamente conectado al suministro eléctrico y de gas.
- Verifique el suministro adecuado del cilindro de respaldo.
- Verifique la correcta conexión y funcionamiento de los vaporizadores.
- Lleve a cabo la comprobación previa al uso, si se detectan errores durante la prueba, se mostrará un mensaje de error donde se indica la causa y una posible solución. Si la comprobación no muestra ningún error, el equipo se pondrá en modo de espera.



No.	Nombre	No.	Nombre
A	Repisa del monitor	K	Pedal de freno
B	Respirador	L	Absorbedor
C	Vaporizador	M	Tubo de conexión de brazo para bolsa
D	Manómetro de presión de bombonas/tubos	N	Brazo ajustable de bolsa
E	Unidad neumática (atrás del panel de indicadores)	O	Controlador de succión
F	Asa	P	Interruptor principal de encendido/apagado
G	Flujo rápido de oxígeno	Q	Válvulas reguladoras de caudal con protección contra la hipoxia
H	Salida común de gases	R	Conjunto de bloqueo de flujo
I	Cajón	S	Medidor del flujo auxiliar
J	Bastidor		

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	



No.	Nombre	No.	Nombre
A	Válvula APL	I	Brazo para bolsa y orificio
B	Interruptor de derivación	J	Válvula inspiratoria antirretorno
C	Válvula espiratoria antirretorno	K	Selector de bolsa/ventilador
D	Cartucho	L	Indicador del manómetro
E	Tubo de conexión de brazo para bolsa	M	Orificio de gas fresco
F	Conector espiratorio del paciente	N	Orificio de escape de APL
G	Orificio del sensor de oxígeno y tapón obturador del orificio	O	Orificio de ventilación
H	Conector inspiratorio del paciente		

Para seleccionar un modo de operación:

- Pulse el botón de modo en la pantalla.
- En el menú “Selección de modo” seleccione el nuevo modo que desea:
 - Control de volumen.
 - Control de precisión de la presión.
 - SIMV + PSV.
 - Pausa inspiratoria.
 - Suspiro
 - Presión de soporte.
- La casilla que está seleccionada se indica mediante una marca de verificación.
- Cada modo activa diferentes opciones, las funciones disponibles son las que se muestran con el texto en negro.
- Para definir o modificar un parámetro:
 - Toque el recuadro correspondiente al parámetro que desee cambiar.
 - Se activarán las flechas hacia arriba y abajo. Pulse el botón hasta que muestre el ajuste deseado.
 - Pulse “Confirme” para confirmar el ajuste.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Use agentes limpiadores recomendados por la institución

Use una solución de detergente suave y agua tibia para eliminar la mugre resistente.

Asegúrese que todos los residuos de agentes limpiadores han sido removidos del equipo.

Las mangueras del sistema de respiración y otros componentes deben esterilizarse según los métodos recomendados por el fabricante.

No limpie ningún componente en máquina de lavado automático.

Realice una limpieza exterior del equipo acorde al procedimiento interno del hospital. Retire toda la suciedad visible y seque el dispositivo si es necesario.

RECOMENDACIONES:

- Apague el equipo.
- Desconecte el cable de poder.

ADVERTENCIAS:

- No use ningún solvente fuerte o material abrasivo.
- No use materiales abrasivos.
- Evite mojar los conectores.
- No permita que el líquido se infiltre en áreas cerradas
- No use agentes abrasivos durante la limpieza.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

NOMBRE		DESCRIPCION
Absorbedor colocado	no	El absorbedor no está correctamente montado en el sistema de anestesia.
Fallo de comunicación.	de	Errores en las comunicaciones internas entre el sistema de control y monitorización.
Presión de gas baja		La presión de gas es inferior a la requerida para el correcto funcionamiento del ventilador. Si no puede mantener la presión de suministro, no utilice el respirador.
Fallo en el sensor O₂		El sensor no está enchufado o funciona mal.
Presión alta		En el modo de control de presión, la presión está por encima del 25% del valor definido.
Respirador inoperativo.		Esta alarma se activa si se detecta un fallo interno. En ningún caso debe utilizarse el respirador en un paciente mientras esta alarma este activa.
Fallo de suministro de O₂		El suministro de oxígeno ha fallado, el ventilador estará funcionando con aire absorbido si dispone de suministro de aire.
Fallo de alimentación y batería baja		Una vez falle la alimentación, el equipo podrá seguir funcionando normalmente alimentado por su batería interna durante mínimo 30 minutos. Cuando queden menos de 15 minutos de capacidad de funcionamiento, se activará la alarma “Batería baja” y el indicador LED parpadeara en rojo. Intente conectar el equipo al fluido eléctrico lo más rápido posible.
Alarma de PEEP		La PEEP medida es más del 25% superior al valor definido o está por encima de 5 cmH ₂ O si no se ha definido.
Error de sensor		Las presiones medidas en el sensor de flujo de las vías respiratorias no se corresponden con las mediciones internas. Se puede deber a una desconexión u obstrucción de los tubos de espirometría.
Alarma de apnea		El ventilador dejo de registrar un volumen corriente durante el tiempo de apnea definido.
Oxígeno bajo		El nivel de oxígeno monitorizado es menor que el nivel definido.
Límite de presión		La presión en las vías respiratorias medida es mayor que el control del limite de presión.